TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG & HUẤN LUYỆN Y KHOA

HƯỚNG DẪN KHÁM & ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG NHI KHOA THEO CÁC LỨA TUỔI

DINH DƯỠNG LÂM SÀNG NHI

Khổ in A4 • 2026.1

Khung tiếp cận ABCD • Kỹ thuật nhân trắc học theo tuổi • Phân loại WHO Z-score • Nhận diện thiếu hụt vi chất

1. KHUNG TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN (MÔ HÌNH ABCD)

A - Anthropometry

Nhân trắc học: Cân nặng (W), Chiều cao/dài (H/L), Vòng đầu (HC), Vòng cánh tay (MUAC), Bề dày nếp gấp da (Triceps skinfold).

B - Biochemical

Cận lâm sàng: Albumin, Prealbumin (bán hủy 2 ngày), CTM (Hb, MCV), Ferritin, 25(OH)D, Canxi/Phospho/ALP, Kẽm huyết thanh.

C - Clinical

Khám lâm sàng: Toàn thân (teo cơ, mất lớp mỡ dưới da, phù dinh dưỡng), Tóc (thưa, dễ rụng), Mắt (khô mắt), Da niêm mạc, Hệ xương.

D - Dietary

Khẩu phần ăn: Bú mẹ/Sữa công thức, thời điểm & cấu trúc ăn dặm, hỏi khẩu phần 24 giờ qua (24-h recall), dị ứng thức ăn, thói quen ăn vặt.

2. QUY TRÌNH THĂM KHÁM & ĐẶC THÙ THEO TỪNG LỨA TUỔI

GIAI ĐOẠN 0 – 6 THÁNG TUỔI (BÚ MẸ HOÀN TOÀN)

NHŨ NHI NHỎ

- **Động lực tăng trưởng:** Sụt cân sinh lý tối đa < 10% trong 7–10 ngày đầu; lấy lại cân lúc 10–14 ngày. Tăng cân trung bình: 25–30 g/ngày (3 tháng đầu), 20 g/ngày (3 tháng sau).
- **Kỹ thuật đo:** Cân máng điện tử (bỏ bỉm/quần áo); Đo chiều dài nằm bằng thước hộp đo nằm (Infantometer); Đo vòng đầu qua điểm nhô nhất ụ chẩm và cung mày.
- **Khám lâm sàng:** Thóp trước (phẳng/trũng), lớp mỡ má (Bichat), độ đàn hồi da, trương lực cơ.
- **Khai thác nuôi dưỡng:** Đánh giá cữ bú (8–12 lần/ngày), khớp ngậm đúng, số tã ướt (≥ 6 tã ướt/ngày chứng tỏ bú đủ sữa mẹ).

⚠ *Cảnh báo:* Sụt cân > 10% sau sinh hoặc không lấy lại cân sau 2 tuần là cờ đỏ thiếu cung cấp sữa mẹ hoặc bệnh lý chuyển hóa/tim bẩm sinh.

GIAI ĐOẠN 6 – 24 THÁNG TUỔI (ĂN DẶM & TĂNG TRƯỞNG NHANH)

ĂN DẶM

- **Chỉ số then chốt:** Vẫn đo chiều dài nằm (đến 24 tháng). Đo **vòng cánh tay (MUAC)** từ 6 tháng: đo điểm giữa mỏm cùng vai và mỏm khuỷu tay trái.
  - MUAC < 115 mm: Suy dinh dưỡng cấp nặng (SAM).
  - MUAC 115 – 125 mm: Suy dinh dưỡng cấp vừa (MAM).
- **Khai thác ăn dặm:** Số bữa/ngày, độ đặc, đủ 4 nhóm chất (đạm, bột, béo, rau/quả). Có kiêng dầu mỡ không?
- **Tầm soát thiếu vi chất:** Thiếu máu thiếu sắt (xanh xao, mệt mỏi), Còi xương thiếu Vitamin D (chuỗi hạt sườn, vòng cổ tay, rụng tóc vành khăn, thóp chậm liền sau 18 tháng).

🚨 *Khám phù dinh dưỡng:* Dùng 2 ngón cái ấn nhẹ trên mu bàn chân 3 giây. Có vết lõm đối xứng hai bên = Phù Kwashiorkor (bắt buộc nhập viện!).

GIAI ĐOẠN 2 – 5 TUỔI (TIỀN HỌC ĐƯỜNG / MẪU GIÁO)

TIỀN HỌC ĐƯỜNG

- **Kỹ thuật đo:** Chuyển sang **đo chiều cao đứng** bằng thước đứng (Stadiometer, 5 điểm chạm tường: gót chân, bắp chân, mông, bả vai, chẩm; mắt nhìn ngang theo mặt phẳng Frankfurt).
- **Chỉ số chính:** Cân nặng theo chiều cao (WHZ) và BMI theo tuổi (BAZ).
- **Khám thực thể:** Đánh giá teo cơ mông/đùi ("mông teo da bọc xương"), khám răng (sâu răng do bú bình đêm/ngậm đồ ngọt), viêm khóe mép, viêm loét miệng.
- **Tâm lý & hành vi ăn:** Biếng ăn tâm lý, kén ăn (food neophobia), ăn vặt gần bữa chính, phụ thuộc màn hình điện thoại khi ăn.

GIAI ĐOẠN 6 – 18 TUỔI (HỌC ĐƯỜNG & VỊ THÀNH NIÊN)

VỊ THÀNH NIÊN

- **Gánh nặng kép dinh dưỡng:** Đồng thời đối mặt Thừa cân/Béo phì và Thấp còi/Thiếu vi chất.
- **Chỉ số then chốt:** BMI theo tuổi (BAZ) là chỉ số nhạy nhất. Đánh giá giai đoạn dậy thì theo **thang điểm Tanner** (ảnh hưởng trực tiếp đến đỉnh tăng trưởng chiều cao).
- **Dấu hiệu chuyển hóa & Béo phì:** Dấu gai đen (Acanthosis nigricans) ở nếp gấp gáy/nách $ ightarrow$ Kháng insulin; Huyết áp cao; Rạn da (Striae); Vẹo cột sống hoặc biến dạng khớp gối vẹo trong (Genu valgum).
- **Hành vi lối sống:** Thức uống có đường, trà sữa, thức ăn nhanh, ít vận động thể lực (< 60 phút/ngày).

3. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG THEO WHO (Z-SCORE)

Chỉ số Nhân trắc	< -3 SD (Rất nặng)	-3 SD đến < -2 SD	-2 SD đến +2 SD	> +2 SD / > +3 SD
WAZ (Cân nặng / Tuổi) Chỉ áp dụng < 10 tuổi	**Nhẹ cân rất nặng**	Nhẹ cân vừa	Bình thường	Đánh giá qua BAZ
HAZ (Chiều cao / Tuổi) Đánh giá thấp còi mạn tính	**Thấp còi rất nặng**	Thấp còi vừa	Bình thường	Rất cao (> +3 SD: u tuyến yên?)
WHZ (Cân nặng / Cao) Áp dụng trẻ < 5 tuổi	**Gầy còm nặng (SAM)**	Gầy còm vừa (MAM)	Bình thường	> +2: Nguy cơ thừa cân

Chỉ số Nhân trắc	< -3 SD (Rất nặng)	-3 SD đến < -2 SD	-2 SD đến +2 SD	> +2 SD / > +3 SD
				> +3: Béo phì
BAZ (BMI / Tuổi) Chuẩn cho trẻ 5 – 19 tuổi	**Gầy còm nặng**	Gầy còm vừa	Bình thường	**> +1 SD: Thừa cân** **> +2 SD: Béo phì** **> +3 SD: Béo phì nặng**

4. CHECKLIST DẤU HIỆU THIẾU HỤT VI CHẤT TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN (HEAD-TO-TOE)

VÙNG ĐẦU – MẮT – TÓC

- **Tóc thưa, dễ gãy rụng, đổi màu đỏ/vàng:** Thiếu Protein, Kẽm, Đồng, Biotin.
- **Thóp rộng, chậm liền (> 18 tháng):** Còi xương thiếu Vitamin D.
- **Quáng gà, vệt Bitot, khô kết mạc:** Thiếu Vitamin A.
- **Mặt "cụ già" (mất mỡ má):** Suy dinh dưỡng thể Marasmus.

KHOANG MIỆNG – RĂNG – DA

- **Viêm mép (Cheilosis), lưỡi đỏ tím (Glossitis):** Thiếu Vitamin B2, B6, B12, Niacin.
- **Chảy máu lợi, chấm xuất huyết quanh nang lông:** Thiếu Vitamin C.
- **Viêm da quanh các lỗ tự nhiên & đầu chi:** Thiếu Kẽm (Acrodermatitis enteropathica).
- **Da khô ráp kiểu vảy cá (phrynoderma):** Thiếu Vitamin A, Acid béo thiết yếu.

HỆ XƯƠNG – CƠ – MÓNG

- **Chuỗi hạt sườn, vòng cổ tay/chân, chân chữ O/X:** Còi xương thiếu Vitamin D / Canxi.
- **Móng tay thìa (Koilonychia), lòng bàn tay nhợt:** Thiếu máu thiếu Sắt.
- **Teo khối cơ thái dương, mông, bắp chân:** Thiếu năng lượng - đạm kéo dài.
- **Phù mu chân đối xứng, da tróc lở mảng ("sơn nứt"):** Kwashiorkor (thiếu đạm nặng).